



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : نجاة كامل على غريب
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الهرم
رقم البطاقة : 27103112101743 رقم التليفون : 01141394553
العنوان : -
العمر (تاريخ الميلاد) : 11-03-1971 المهنة : بدون عمل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نجاة كامل علي غريب National ID: 27103112101743	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient Name	: الأستاذة / نجاء كامل علي عريش	Request No.	: 13003229
Patient No.	: 27103112101743	Request Date	: 10/05/2023
Path No.	: 1371/2023	Verification Date	: 11/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: برنامج دار السلام - نقطة الدولة
Age	: 52 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 9/5/2023, 3:04 pm.

Gross Examination

- Fragmented grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (SP1), PR clone (1E2), HER-2 CLONE (4B5), & Ki67 (30-9)

Microscopic Examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) GII.
- * Ductal carcinoma in situ: minimal.
- * Perineural invasion: No.
- * Angioinvasion: No.
- * IPT

ER: Moderate to strong nuclear reaction in 2% of tumor cells (Allred score 5/8)

PR: Strong nuclear reaction in 5% of tumor cells (Allred score 5/8)

Her2: Moderate complete membrane reaction in >10% of tumor cells. (score 2+)

SISH: Not amplified.

(Average Her2 copy No.: 3.15, Her2/CEP17 ratio: 1.4)

Ki 67: Positive in 50% of tumor cells.

Diagnosis

Left breast mass, Tru-cut biopsy.

Invasive duct carcinoma, GII with minimal DCIS.

ER: Positive (5/8)

PR: Positive (5/8)

HER2: Equivocal (score 2+)

Verified by :

Patient Name : الأستاذة / نوال كامل طلي حبيب

Patient No. : 27103112101743

Birth No. : 4612/23

Sex : Female

Age : 52 Y

Referring Doc :

Request No. : 13005592

Request Date : 31/12/2023

Verification Date : 16/01/2024

Financial Category : تغطية الدولة - فورنوفاي سلامت

Department : Out Patient

Registered by : maria mohamed youss

Pathology Report

ii).

- Maximal tumor diameter 1x1 mm.
- Actual tumor cellularity: 1%, tumor necrosis index: 99%.
- Free nipple and areola
- Lymph nodes were positive in (4/13) with extracapsular extension.
- Free deep margin of invasive lump.
- 0.2 ml least deep margin for DCIS.
- Stage: ypT1(mic), ypN2.
- RCB: 2.47, RCB class I).

Signature

Prof. Dr. Gamal Abdelatty
Dr. Heba Hassan

Verified by
DR. Maria Habib

Printing Date : 16/01/2024 11:11:45

Page 1 of 1

Printing By : maria mohamed youss



Patient Name: Ngah Kamel Ali Gharib	Date: 15/06/2023
Exam: ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age: 52 Year(s)
Medical ID: 1371/2023	Pat. ID: 38701

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

left breast palpable lump, pathologically proven IDC G II, with DCIS.

Technique:

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast shows UOQ posterior third partially indistinct irregular mass lesion, of high density, associated with asymmetry and increased skin thickening.
- Complementary ultrasound revealed left breast irregular hypoechoic altered parenchyma, with indistinct margins mass, with vascularity detected within on color Doppler, seen at 2 o'clock, measuring 1.5x3.1cm, consistent to the palpable lump.
- No right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.
- Pathological left axillary lymph nodes, level I, II, III and supra-clavicular, the largest is axillary, measuring 2.3x2.7cm
- Nonspecific right axillary LN.

Opinion:

- Left breast UOQ pathologically proven malignant process (BIRADS 6)
- Pathological left axillary level I, II, III and supra-clavicular LNs.
- Benign findings right breast (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

15/06/2023 2:20 PM



Patient Name: Ngah Kamel Ali Gharib	Date : 05/06/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 52 Year(s)
Medical ID:2023/2057	38701

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Reported case of breast cancer.

Findings:

- Left breast UOQ soft tissue lesion is seen measuring about 35 x 2 mm with left breast edema and left breast skin thickening.
- Multiple enlarged pathological left axillary level I lymph nodes the largest one is seen measuring about 28 x 27 mm.
- No sizable pulmonary nodules, masses, consolidative patches or cavitary lesions.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Normal appearance of the chest wall.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- ***Left breast UOQ soft tissue lesion with ipsilateral pathological axillary lymph nodes.***
- ***No CT evidence of pulmonary metastatic disease.***

Dr. Mark Adel

Dr. Amr Farouk, M.D.